AgendaHC — Documento de Validação e Especificação de Negócio

> **Padrão Oficial SETISD / HC-UFPE (HU Brasil) — Fase 0 (Alinhamento de Negócio) Público-alvo:** Central de Marcação de Exames, áreas solicitantes e Equipe de TI. **Objetivo:** Descrever o processo em linguagem de negócio, para validação e tomada de decisão antes de qualquer codificação.

---

1. Identificação do Projeto e Contexto Institucional

Campo	Descrição
Nome do Sistema	AgendaHC
Área Solicitante / Cliente	Central de Marcação de Exames do HC-UFPE
Instância Superior Competente	[A definir]
Líder Técnico (SETISD)	[A definir]
Objetivo Estratégico HU Brasil	[qualificar o acesso do paciente aos serviços de apoio diagnóstico]

---

2. O Problema que Queremos Resolver

Hoje o pedido de agendamento de exames chega por um formulário do Google, vira uma planilha e precisa ser conferido e redigitado manualmente no AGHU pela Central de Marcação. Esse vai e volta entre planilha e AGHU gera retrabalho e erros constantes, principalmente no número de solicitação, que é obrigatório para marcar o exame e que muitos pacientes preenchem errado, às vezes colocando o número de celular no lugar.

Isso não pode continuar porque cada pedido com erro precisa ser investigado ou devolvido, o que consome o tempo da equipe e atrasa o atendimento. Além disso, a fila hoje segue apenas a ordem de chegada na planilha, sem critério formal de prioridade. Isso dificulta atender primeiro quem precisa, como os pacientes de hemodiálise, e também levar em conta a data de retorno do paciente ao médico ou a distância entre a cidade onde ele mora e o hospital. A

gestão também não tem uma visão clara de quantos pedidos estão pendentes, por exame, nem de quanto tempo o paciente espera.

---

3. Como o Processo Funciona Hoje (A Rotina Atual)

O pedido de exame é feito pelo médico no AGHU durante a consulta, e o paciente sai com um ticket impresso que traz o número da solicitação. Esse ticket é gerado exclusivamente pelo AGHU e não pode ser alterado. Com ele em mãos, o paciente preenche um formulário do Google informando o exame, a data de retorno ao profissional que pediu o exame, seu nome, o número do prontuário, a idade, o município onde mora, o número da solicitação e um telefone ou WhatsApp para receber a resposta. O formulário mostra uma foto do ticket indicando qual número digitar, mas os erros continuam frequentes.

As respostas caem numa planilha no Google Drive. A Central de Marcação abre cada pedido, copia o número da solicitação e o pesquisa no AGHU, que mostra o paciente, a especialidade de origem e a consulta vinculada. Se o número estiver errado, o AGHU informa que a solicitação não foi encontrada e o pedido fica travado. Se estiver certo, a equipe escolhe uma vaga, marca o exame no AGHU, avisa o paciente pelo WhatsApp e pinta a linha da planilha de verde. Os pedidos ainda não tratados ficam em branco.

As vagas costumam ser abertas a cada dois meses, mas podem ser liberadas a qualquer momento, por exemplo quando chegam novos médicos a uma unidade. Para evitar uma fila impossível de atender, os exames sem vaga ficam sinalizados no formulário, e o paciente é orientado a procurar também a unidade básica de saúde, já que parte das vagas do hospital é repassada mensalmente ao estado. As prioridades são tratadas de forma informal: a equipe de nefrologia envia uma lista dos pacientes de hemodiálise que precisam fazer ultrassom das vias urinárias com mais urgência, e cada exame tem particularidades que a equipe conhece de memória.

---

4. O Que a Nova Solução Deve Entregar (Resultado Esperado)

A proposta é substituir a planilha, e as trocas informais que giram em torno dela, por um sistema interno do hospital que funcione ao lado do AGHU. Nele, cada pedido é conferido com os dados oficiais do AGHU antes de chegar à fila, e a Central de Marcação passa a trabalhar com uma fila organizada por exame e por prioridade, e não mais com uma planilha lida linha por linha.

Os ganhos imediatos esperados são o fim dos pedidos com solicitação inválida chegando à equipe, menos tempo gasto em conferência manual, uma fila que respeita as regras de cada exame e uma visão clara, para a gestão, da demanda e das pendências.

---

5. Como Será o Trabalho no Novo Sistema (O Novo Fluxo)

O pedido do paciente chega ao sistema com o número da solicitação e os mesmos dados que hoje são pedidos no formulário. O canal por onde esse pedido entra ainda precisa ser decidido (ver Seção 9). O sistema confere a solicitação com o AGHU assim que o pedido chega. Se ela existir e corresponder ao paciente, o pedido entra na fila do exame correspondente. Se não, o pedido é barrado e o motivo fica registrado, para que o paciente seja orientado a corrigir.

A Central de Marcação abre a fila já organizada, com os pedidos válidos e as prioridades aplicadas. Nessa ordenação entram a lista de pacientes prioritários, a data de retorno ao médico e a distância entre o município do paciente e o hospital. A equipe continua fazendo a marcação final no AGHU, que segue sendo o sistema oficial, e registra no novo sistema que o pedido foi agendado. Esse registro substitui a linha pintada de verde na planilha. A gestão acompanha em um painel quantos pedidos existem por exame, quantos já foram atendidos e há quanto tempo cada um espera.

---

6. Quem Participa do Processo

O **paciente** hoje preenche um formulário sem nenhuma conferência. No novo sistema, seu pedido será validado antes de entrar na fila, e ele será avisado do resultado. Ele não terá acesso a informações de outros pacientes nem à fila completa. Se o paciente vai interagir diretamente com o sistema ou continuar usando outro canal ainda está em aberto.

A **Central de Marcação** hoje alterna entre a planilha, o AGHU e o WhatsApp e corrige erros manualmente. No novo sistema, trabalhará a partir de uma fila já validada e organizada, marcando no AGHU e registrando o resultado. Ela não altera as regras de prioridade por conta própria.

As **áreas que definem prioridades**, como a nefrologia, hoje enviam listas avulsas. No novo sistema, suas regras e listas passam a ser aplicadas de forma padronizada na fila. Elas não fazem agendamentos.

A **gestão** hoje não tem visão consolidada da demanda. No novo sistema, acompanhará indicadores em um painel, apenas para consulta, sem editar pedidos.

---

7. Regras de Negócio Inegociáveis (RNs)

RN-01 (Solicitação válida obrigatória): nenhum pedido entra na fila sem um número de solicitação que exista no AGHU e corresponda ao paciente.

RN-02 (AGHU como sistema oficial): o novo sistema apenas consulta o AGHU e nunca grava nada nele. A solicitação do exame, a marcação final e o ticket do paciente continuam sendo feitos exclusivamente no AGHU.

RN-03 (Prioridade por exame): cada exame pode ter sua própria regra de prioridade, definida pela área responsável, como a prioridade dos pacientes de hemodiálise no ultrassom das vias urinárias. Na ausência de regra, vale a ordem de chegada.

RN-04 (Data de retorno e antecedência): a data de retorno ao médico orienta o agendamento, para que o exame seja feito antes da próxima consulta. O sistema também não deve sugerir vagas que o paciente não consiga aproveitar por causa da distância entre seu município e o hospital. A antecedência mínima exata será definida pela área de negócio.

RN-05 (Respeito à disponibilidade de vagas): exames sem vagas abertas não recebem novos pedidos, a menos que a gestão decida manter uma lista de espera (ver Seção 9).

RN-06 (Dados mínimos do paciente): o sistema coleta apenas os dados necessários para identificar o paciente, o pedido e a forma de contato, em conformidade com a LGPD.

RN-07 (Histórico preservado): todo pedido guarda o registro de quando foi feito, quem o tratou e qual foi o resultado. Esse histórico não pode ser apagado.

RN-08 (Acesso institucional): a equipe interna acessa o sistema com o login institucional do hospital, para que toda ação fique vinculada ao seu autor.

RN-09 (Escopo interno): a fila tratada pelo sistema é apenas a do hospital. Pacientes encaminhados pela regulação do SUS ou pela Secretaria Estadual de Saúde ficam fora do escopo.

---

8. Painel de Gestão e Indicadores Estratégicos (KPIs)

O painel deve mostrar, por exame, quantos pedidos estão na fila e há quanto tempo, em média, os pacientes esperam entre o pedido e o agendamento. Também deve mostrar quantos pedidos foram barrados por solicitação inválida, o que ajuda a medir o problema atual e a ver onde a orientação ao paciente precisa melhorar. Deve mostrar ainda quantos exames foram agendados depois da data de retorno do paciente ao médico, já que esses casos indicam falha no atendimento. Por fim, deve mostrar quantos pedidos prioritários existem e se estão sendo atendidos antes dos demais.

---

9. Matriz de Pontos de Decisão

#	Ponto a Decidir	Impacto no Processo	Quem deve decidir?	Status
1	O paciente fará o pedido diretamente no novo sistema ou por outro canal,	Define se haverá tela para o paciente e como a validação da	TI e Central de Marcação	🟡 Em definição

#	Ponto a Decidir	Impacto no Processo	Quem deve decidir?	Status
	com o sistema sendo usado só pela equipe interna?	solicitação chega até ele.		
2	Quais dados o paciente informa para confirmar que a solicitação é dele?	Define a segurança da validação e a facilidade de uso.	Central de Marcação e TI	🟡 Em definição
3	Qual a regra de prioridade de cada exame e quem é responsável por mantê-la?	Define como a fila é ordenada.	Áreas solicitantes e gestão	🟡 Em definição
4	Qual a antecedência mínima de agendamento conforme o município do paciente?	Evita oferecer vagas que o paciente não consegue aproveitar.	Central de Marcação	🟡 Em definição
5	Exame sem vaga bloqueia o pedido ou gera lista de espera?	Define se a demanda reprimida passa a ser registrada.	Gestão da Central	🟡 Em definição
6	Com que frequência os dados do AGHU precisam ser atualizados no sistema?	Define se a validação usa dados do momento ou de algumas horas atrás.	TI e Central de Marcação	🟡 Em definição

#	Ponto a Decidir	Impacto no Processo	Quem deve decidir?	Status
7	Como o paciente será avisado de que o exame foi agendado?	Define se o WhatsApp continua como canal e se o sistema precisa apoiar esse contato.	Gestão da Central	🟡 Em definição

---

Como este documento se liga aos demais

Este documento é a ponte entre a área de negócio e a equipe de engenharia. Depois de validado com a Central de Marcação, suas Seções 2 a 4 alimentam o 01-visao.md. As Seções 5 a 7 viram requisitos e casos de uso. A Seção 8 orienta as telas de acompanhamento, e a Seção 9 define os parâmetros que ainda precisam ser configurados antes da implementação.